



PROTOCOLO DE PRÓTESIS COMPLETA

Clínica Universitaria de Odontología

INTRODUCCIÓN

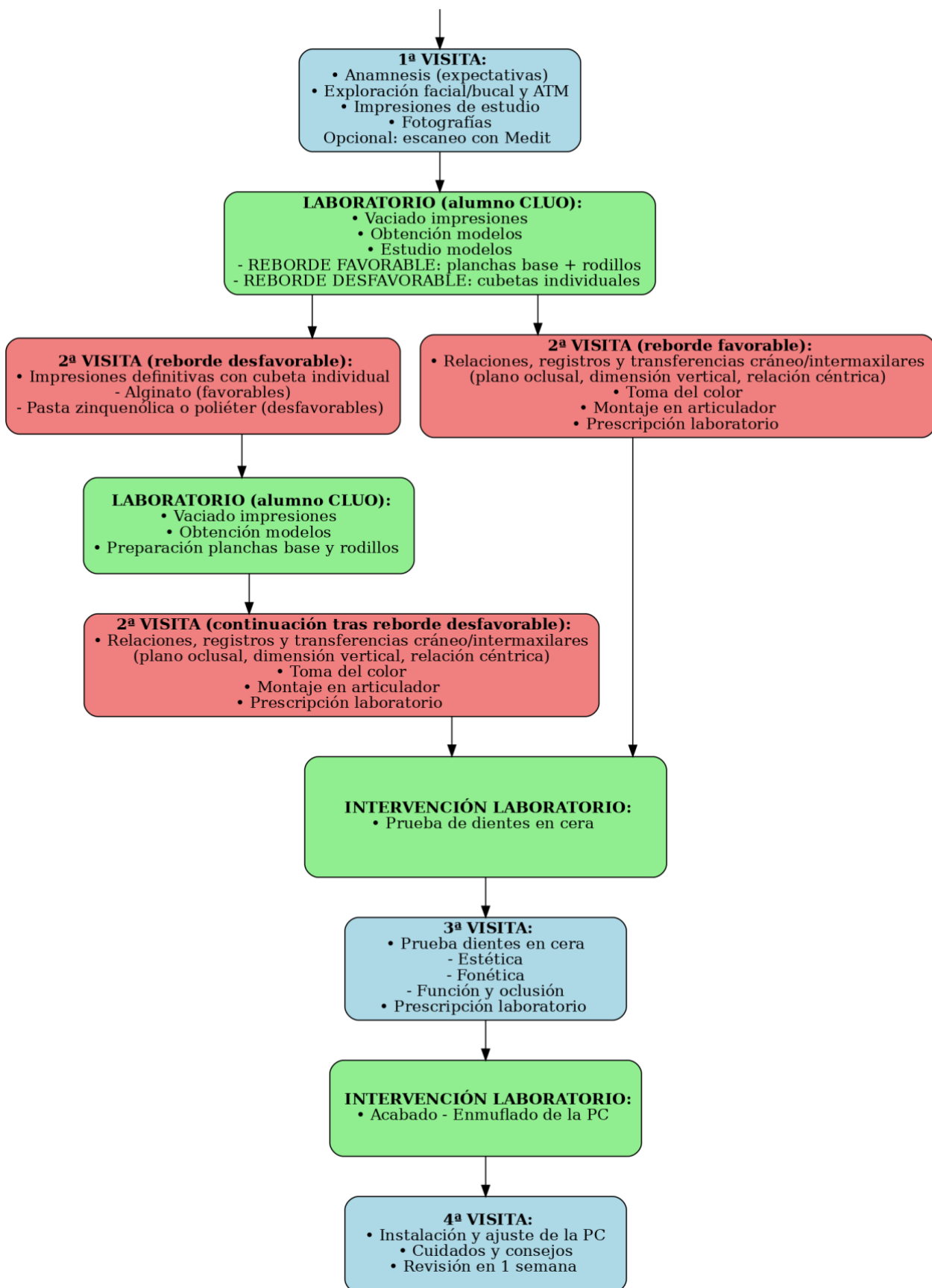
La pérdida de la totalidad de los dientes de uno o ambos maxilares conlleva la pérdida de la función masticatoria, déficit de la función fonética y de la estética facial. También afecta de forma negativa psicológicamente al paciente.

OBJETIVOS

Recuperar las funciones anteriormente mencionadas y otras alteraciones biológicas como:

- Pérdida de la función masticatoria, funcional y estética.
- Alteración articular.
- Posible disminución de la dimensión vertical.
- Alteración perfil facial.
- Disminución de la cresta ósea.

FLUJO DE TRABAJO - PRÓTESIS COMPLETAS CLUO



PROTOCOLO DE PRÓTESIS COMPLETA

1º VISITA - PLANIFICIACIÓN

1. DIAGNÓSTICO

- Historia clínica (médica y dental).
 - o Anamnesis y objetivos del paciente
 - o Valoramos actitud y expectativas del paciente.
- Según el tipo de reborde el pronóstico será más o menos favorable. ¿Desde cuándo? ¿A qué lo atribuye?
- Exploración extraoral: INSPECCIÓN (de frente: Abrir y cerrar la boca, forma de la cara, altura facial. Perfil: rágades comisurales, labios hendidos...). PALPACIÓN: ATM, músculos, terminaciones nerviosas, glándulas...
- Exploración intraoral: mucosas, pliegues y frenillos, lengua, suelo de la boca y glándulas salivales, saliva, rebordes alveolares.

2. ESTUDIO DEL CASO

a) Toma de impresiones con cubeta estándar y alginato de ambas arcadas (cubetas metálicas tipo RIM-LOCK).

Nota: Si las condiciones de tiempo son posible se escanearía al paciente con escáner digital Médit ambas arcadas para practicar la técnica.

b) Fotos del paciente: extraoral e intraoral. En caso de tener un paciente con reborde desfavorable, se recomienda marcar con rotulador indeleble la línea cero o anatómica.

c) Toma del color aprovechando la presencia de la cámara réflex.

3. EXPLICACIÓN DEL CASO AL PACIENTE

- Explicaremos al paciente la solución encontrada a su caso según el estudio de los modelos.
- Comentaremos los distintos materiales que podemos utilizar, así como sus ventajas e inconvenientes.
- Explicaremos número de visitas a realizar (aproximadamente).

Pruebas de Laboratorio (por el alumno en la CLUO)

- Vaciado de impresiones (escayola tipo IV o V de la ADA para la obtención de modelos)
- Obtención de modelos + Zocalado (Confección de base primaria y secundaria)
- Estudio de modelos → Paralelización de modelos: determinación de modelos: retentivos (reborde favorable) o expulsivos (reborde desfavorable):
 - a) Si REBORDE **favorable**: Preparación de planchas base y rodillos para la 2ª visita.
 - b) Si REBORDE **desfavorable**: confección de cubetas individuales para la 2ª visita → Nos ayudaremos de la fotografía, marcamos los límites de la línea cero o anatómica en los modelos → Confeccionamos las cubetas individuales SIN ESPACIADOR (para pasta zinquenólica) o CON ESPACIADOR (poliéter) según los límites ya conocidos.

2ª VISITA

SI REBORDE FAVORABLE

- En la segunda visita, se **comprueban las dimensiones de las planchas base superior e inferior y sus rodillos**, así como que éstas cumplen con las cualidades funcionales de las prótesis estomatológicas.
- Para la **arcada superior**, se adecuaría la plancha base y el rodillo superior al paciente comprobando:
 - soporte labial
 - Inclinación del plano oclusal (anterior: paralelo a la línea bipupilar y sobresaliendo entre 0 y 1mm respecto al labio en reposo. Posterior: paralelo al plano de Frankfurt)
 - Marcamos de la línea media, línea de la sonrisa y línea de los caninos.
- **Transferencia del modelo superior al articulador** mediante registro con arco facial. Al no ser un paciente dentado, realizaremos marcas sobre la cara oclusal de los sectores posteriores según lo enseñado, para usar una horquilla de dentado, o bien calentaremos la horquilla de desdentado (tridente) y lo solidarizaremos al rodillo superior sin modificarlo.
- **Relaciones intermaxilares:**
 - **Dimensión vertical:** Para la determinación de la dimensión vertical, utilizaremos métodos estáticos (aplicación de los diferentes cánones para relacionar los 3 tercios de la cara) y dinámicos (más precisos).

Para ello:

1. Marcaremos dos puntos en el paciente, el subnasal y el pogonion.
2. Mandaremos al paciente a realizar una apertura máxima de la boca hasta conseguir fatiga muscular.
3. Mandamos cerrar **sin forzar** y anotamos la distancia entre los 2 puntos y realizamos este proceso 4 veces. Con esto obtendríamos un valor medio de la **Dimensión Vertical en Reposo (DVR)**.

4. Para obtener la **Dimensión Vertical en Oclusión (DVO)**, mandamos al paciente a tragar saliva, y en esa posición final anotamos la distancia entre los 2 puntos elegidos. Realizaremos este proceso también 4 veces.
 5. Finalmente obtendremos un valor medio cuya discrepancia con la dimensión vertical en reposo no debe ser muy grande, pero sí menor.
 6. Colocamos ambas planchas base con los rodillos (superior e inferior) y mandamos al paciente a deglutir.
 7. Rebajamos **los rodillos inferiores** hasta que la distancia entre los puntos subnasal y pogonion sea igual a la DVO y haya congruencia entre las caras oclusales de los rodillos superior e inferior.
 8. Comprobamos la viabilidad de la DV mediante métodos métricos (canon de Willis o Mc Gee), estéticos (posición de labios, altura del tercio facial inferior, competencia labial...) y fonéticos (pronunciando los fonemas M, F, V, S...).
- **Relación céntrica (RC):** Una vez aceptada la DV, se determina y registra la relación céntrica. Para ello:
 1. Para la manipulación de la mandíbula se pueden emplear cualquiera de las dos técnicas enseñadas (Ramfjord y Dawson).
 2. Al haber muescas en la cara oclusal del rodillo superior (que hemos usado para transferir el modelo superior al articulador), para registrar esta posición intermaxilar se posiciona una lámina reblandecida de **cera alluwax** sobre la cara oclusal del rodillo inferior (ambos lados)
 3. Antes de que ésta endurezca, se procede a manipular la mandíbula del paciente para determinar y registrar la RC entre ambas arcadas. Las huellas de la arcada superior deberán quedar marcadas en la cera alluwax de los rodillos inferiores de tal manera que nos dé suficiente estabilidad para montar el modelo inferior en el articulador. De no ser así, se procederá a modificar el rodillo inferior.
 - Montaje de modelos:
 1. Con la ayuda del arco facial que previamente hemos utilizado, montamos el modelo superior en el articulador con la técnica ya descrita. Nos aseguramos en este momento de tener el **puntero incisal a CERO, la inclinación condílea a 40º y los ángulos de Bennet a 15º**.
 2. Una vez montado el modelo superior, procedemos a montar el modelo inferior retirando la mesa de transferencia con la horquilla y

poniendo en su lugar el modelo inferior del paciente junto con la plancha base y los rodillos, que solidarizamos al superior haciendo coincidir las huellas obtenidas entre ambos.

- **Solicitud al laboratorio** de prueba de **dientes en cera**

Nota: Se solicita al laboratorio para que realice el encerado de los dientes, recordando siempre incluir en la prescripción protésica que la sobremordida debe ser igual a 0 y el resalte de 3mm. Asimismo, debemos indicar el color, tamaño y forma de dientes elegidos, empleando para ello la guía CHROMASCOP. Pedimos que nuestro encerado tenga **Oclusión Balanceada Bilateral (OBB)**.

SI REBORDE DESFAVORABLE

En el caso de un paciente que presente un reborde desfavorable en esta cita realizaremos la toma de impresión con cubeta individual con pasta zinquenólica o con poliéter. Tras lo cual, realizaremos las pruebas de laboratorio a cargo del alumno en la CLUO (ver esquema siguiente).

Pruebas de Laboratorio (por el alumno en la CLUO)

- Vaciado de impresiones (escayola tipo IV o V de la ADA para la obtención de modelos)
- Obtención de modelos + Zocalado (Confección de base primaria y secundaria)
- Preparación de planchas base y rodillos para la 2ª visita “continuación” (nueva cita).

En una nueva visita citaremos al paciente para realizar todos los pasos descritos en la 2ª visita (se **comprueban las dimensiones de las planchas base superior e inferior y sus rodillos y registros intermaxilares y craneomaxilares**) y solicitaremos al laboratorio la prueba de dientes en cera.

3ª VISITA

1. Tras comprobar en el articulador que la prueba de dientes se corresponde con lo solicitado, se cita al paciente y se realiza la prueba de dientes en cera.
2. En dicha prueba, volveremos a comprobar las cualidades funcionales de las prótesis, esta vez con dientes montados con cera en lugar de rodillos, valoraríamos:
 - a. Características de los dientes:
 1. Tamaño
 2. Forma
 3. Color de dientes
 - b. Estética: altura facial, posición de labios, posición borde incisivos superiores con labio en reposo, estética dental general, mandamos sonreír al paciente y comprobamos armonía estética, ...
 - c. Fonética: mandamos al paciente pronunciar diferentes fonemas (M,F,V,S).
 - d. Función: estabilidad oclusal, correlación entre arcadas, retención estática y dinámica, soporte, estabilidad, comprobar **ausencia** de guía canina.
3. Corregiremos los defectos y enviaremos una nueva prescripción al laboratorio.

Prueba de Laboratorio

- Acabado de la PC “Enmuflado de la PC”

4ª VISITA

1. Comprobamos en el paciente todos los parámetros medidos en la prueba de dientes en cera:
 - Características de los dientes:
 - Tamaño
 - Forma
 - Color de dientes
 - Estética: altura facial, posición de labios, posición borde incisivos superiores con labio en reposo, estética dental general, mandamos sonreír al paciente y comprobamos armonía estética, ...
 - Fonética: mandamos al paciente pronunciar diferentes fonemas (M,F,V,S).
 - Función: estabilidad oclusal, correlación entre arcadas, retención estática y dinámica, soporte, estabilidad, comprobar **ausencia** de guía canina.
2. Chequeamos la oclusión hasta conseguir una OBB directamente en el paciente. **Por motivos clínicos y didácticos, en esta asignatura sólo emplearemos la obtención de “modelos de remontaje”, el remontaje y ajuste de la PC del paciente en el articulador en el caso de haber mucha discrepancia entre la prueba de dientes en cera y el enmuflado de la misma al probar la PC en el paciente. De no ser así, obviaríamos este paso.**
3. Posteriormente, se le explicaría al paciente las instrucciones de manejo, cuidado y mantenimiento de las PC.
4. Citaremos al paciente en 1 semana